

Syllabus détaillé de la séance probatoire

« Du protégé au sujet de droits : transformations du champ du handicap et nouvelle posture du travail social »

Pierre Brasseur · HETS Genève · 5 juin 2026

Contents

SYLLABUS DÉTAILLÉ — SÉANCE PROBATOIRE	1
1. Positionnement et finalité	1
2. Compétences PEC20 ciblées	2
3. Vignette d'entrée et fil rouge	2
4. Plan de la séance	3
5. Développement détaillé du contenu	3
5.1 Pourquoi parler de « modes d'intervention » plutôt que de « prise en charge » ? (5-8 min)	3
5.2 Les quatre modèles du handicap (8-18 min)	4
5.3 Les transformations contemporaines (19-28 min)	6
5.4 Les trois tensions de la posture professionnelle (29-33 min)	8
5.5 Activité d'application <i>think-pair-share</i> (33-38 min)	10
5.6 Synthèse et ouverture (38-40 min)	10
6. Modalités d'évaluation des apprentissages de cette séance	10
7. Bibliographie complète (par ordre alphabétique)	11

SYLLABUS DÉTAILLÉ — SÉANCE PROBATOIRE

HETS Genève · Bachelor en travail social · 5 juin 2026

Titre : « Du protégé au sujet de droits : transformations du champ du handicap et nouvelle posture du travail social »

Module : « Handicap, autonomie et travail social » — séance 4 sur 13 **Durée :** 40 minutes d'exposé + 20 minutes de questions **Public :** 25-40 étudiant-es de Bachelor TS, semestre 4

1. Positionnement et finalité

Cette séance est la quatrième d'un module de spécialisation Bachelor en travail social. Les trois séances précédentes ont posé les jalons : (S1) état des lieux quantitatif et politique du champ du handicap en Suisse¹ ; (S2)

¹Office fédéral de la statistique (OFS) (2022). *Statistique de l'égalité des personnes handicapées*. Neuchâtel : OFS. Selon cette source, environ 1,7 million de personnes vivent avec un problème de santé durable en Suisse. Voir aussi Inclusion Handicap (2022), *La Suisse en mauvaise position : communiqué de presse sur les Observations finales du Comité ONU CDPH*, Berne.

histoire longue, anthropologie historique de l'infirmité, sociologie du stigmate² ; (S3) présentation systématique des quatre modèles théoriques du handicap³.

La présente séance opère trois mouvements articulés :

1. **Reprise et systématisation** des quatre modèles théoriques sous forme de tableau opérationnel ;
2. **Mise en relation** avec les transformations contemporaines du champ — désinstitutionnalisation⁴, autodétermination⁵, financement orienté personne⁶ — et leur traduction dans le cadre normatif suisse et genevois ;
3. **Analyse des effets sur la posture professionnelle**, à travers trois tensions structurelles que les futur-es TS rencontreront dans leur formation pratique et dans leurs premiers postes⁷.

La finalité pédagogique est double : **doter les étudiant-es d'une grille d'analyse théorique** suffisamment dense pour identifier les modèles à l'œuvre dans leurs lieux de formation pratique, et **les outiller pour adopter une posture réflexive** sur leur propre rôle professionnel dans un champ traversé par des injonctions contradictoires.

2. Compétences PEC20 ciblées

Cette séance contribue à l'acquisition des compétences suivantes du Plan d'études cadre Bachelor en travail social (HES-SO, 2020) :

- **C1** Orienter son action professionnelle sur les principes de l'action sociale et la mission de l'institution ;
- **C2** Analyser les implications éthiques et politiques de sa pratique ;
- **C3** Identifier et analyser les situations et processus sociaux ;
- **C4** Construire, planifier et réaliser des projets d'intervention ;
- **C5** Identifier les ressources institutionnelles et les mobiliser ;
- **C7** Mobiliser des références théoriques pour comprendre les situations ;
- **C8** Développer une posture professionnelle réflexive ;
- **C9** Coopérer et coordonner son action avec d'autres acteurs ;
- **C11** Évaluer et adapter ses interventions.

3. Vignette d'entrée et fil rouge

Léa, 22 ans, a une trisomie 21. Elle vit à L'Atelier, un dispositif d'accompagnement des jeunes adultes géré par la Fondation Ensemble à Genève. Un matin, en réunion d'équipe, son éducatrice référente rapporte cette demande : « Je veux un appartement à moi et un amoureux qui dort là. » La mère de Léa, qui vient chaque week-end, demande à l'équipe de « la raisonner ».

²Stiker, H.-J. (1982/2013). *Corps infirmes et sociétés. Essais d'anthropologie historique* (3^e éd.). Paris : Dunod. Goffman, E. (1963/1975). *Stigmate. Les usages sociaux des handicaps*. Paris : Minuit. Ville, I., Fillion, E., & Ravaud, J.-F. (2020). *Introduction à la sociologie du handicap. Histoire, politiques et expérience* (2^e éd.). Louvain-la-Neuve : De Boeck.

³Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Basingstoke : Macmillan. Fougeyrollas, P. (2010). *La funambule, le fil et la toile. Modèles conceptuels appliqués au handicap*. Québec : Presses de l'Université Laval. Nussbaum, M. (2006). *Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership*. Cambridge (MA) : Belknap/Harvard.

⁴Mansell, J., & Beadle-Brown, J. (2010). Deinstitutionalisation and community living : Position statement of the Comparative Policy and Practice Special Interest Research Group of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities. *Journal of Intellectual Disability Research*, 54(2), 104-112.

⁵Wehmeyer, M. (1996). Self-determination as an educational outcome : Why is it important to children, youth, and adults with disabilities? In D. J. Sands & M. L. Wehmeyer (Eds.), *Self-determination across the life span: Independence and choice for people with disabilities* (pp. 17-36). Baltimore : Brookes. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. New York : Guilford.

⁶Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (2020). *Évaluation finale de la contribution d'assistance. Rapport de synthèse*. Berne : OFAS. Pour une analyse comparée des politiques *cash-for-care*, voir Le Bihan, B., Da Roit, B., & Sopadzhyan, A. (2019). The turn to optional familialism through the market : Long-term care, cash-for-care, and caregiving policies in Europe. *Social Policy & Administration*, 53(4), 579-595 ; Glendinning, C. (2008). Increasing choice and control for older and disabled people : A critical review of new developments in England. *Social Policy & Administration*, 42(5), 451-469.

⁷Clot, Y. (2008). *Travail et pouvoir d'agir*. Paris : PUF. Lipsky, M. (1980/2010). *Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services* (30th anniv. ed.). New York : Russell Sage Foundation. Tronto, J. (2009). *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*. Paris : La Découverte.

Cette vignette n'est pas un cas clinique fermé. C'est un **dispositif pédagogique** au sens de Schön⁸ : une situation qui résiste, qui contraint l'enseignant et les étudiant·es à mobiliser leurs ressources théoriques pour la penser. Elle ouvre la séance (5 min), traverse trois moments de retour (18 min, 26 min, 33-38 min) et la clôt. Elle est référée à un dispositif réel — L'Atelier de la Fondation Ensemble, qui accompagne effectivement des jeunes adultes avec déficience intellectuelle à Genève⁹.

4. Plan de la séance

Temps	Contenu	Activité
0-5 min	Vignette d'ouverture + plan + énigme	Question rhétorique
5-8 min	« Modes d'intervention » vs « prise en charge »	Exposé
8-13 min	Modèles 1-3 : médical, social, MDH-PPH	Levée de main (1 min à 11 min)
13-18 min	Modèle 4 : droits humains + capacités	Lecture de l'art. 19 CDPH
18-19 min	Retour à la vignette : où se situent la mère, l'équipe ?	Réponse libre
19-23 min	Transformations (1) : désinstitutionnalisation	Exposé
23-26 min	Transformations (2) : autodétermination, pair-aidance	Exposé
26-28 min	Transformations (3) : financement orienté personne	Exposé
28-29 min	Micro-interaction	Réponse libre
29-33 min	Trois tensions de posture	Exposé
33-38 min	Activité <i>think-pair-share</i>	Travail en binôme
38-40 min	Synthèse et ouverture	Clôture

5. Développement détaillé du contenu

5.1 Pourquoi parler de « modes d'intervention » plutôt que de « prise en charge » ? (5-8 min)

Le lexique du travail social est un **outil de pensée** au sens où Stiker entendait l'analyse anthropologique des catégories¹⁰. « *Prise en charge* » implique une personne-objet, une asymétrie radicale entre celui ou celle qui prend et celle ou celui qui est pris·e. « *Accompagnement* » humanise mais conserve une asymétrie : on accompagne quelqu'un qui ne marcherait pas seul. « *Modes d'intervention* », formulation retenue dans l'intitulé du poste HETS 309 et du module, suppose une personne-sujet et des choix professionnels argumentés.

⁸Schön, D. A. (1983/1994). *Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Montréal : Éditions Logiques. La situation « qui résiste » est au cœur de la *reflection-in-action*.

⁹La Fondation Ensemble (Genève), dirigée à ce jour par J. Laederach, gère cinq structures de la petite enfance à l'âge adulte pour environ 250 personnes avec déficience intellectuelle. Voir aussi le projet d'habitat coopératif inclusif *Sureaux* (Chêne-Bougeries), partenariat Codha-Fondation Ensemble, emménagement mars 2021, 19 logements dont 3 pour Ensemble — primé par Coopératives Habitat Suisse (catégorie partenariat).

¹⁰Stiker, H.-J. (1982/2013), op. cit., *passim*. La thèse centrale : la modernité construit le paradigme de la « réadaptation » qui « ramène à la norme, à l'identique » et « désigne par là même comme différent ». Voir aussi la critique du même mouvement par Winance, M. (2007). Being normally different ? Changes to normalization processes : From alignment to work on the norm. *Disability & Society*, 22(6), 625-638.

Ce déplacement lexical correspond à un déplacement épistémique documenté par les *disability studies* anglo-saxonnes depuis les années 1970¹¹ et par la sociologie du handicap francophone depuis les années 2000¹². Il rejoint enfin la révolution juridique opérée par la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en 2006¹³.

5.2 Les quatre modèles du handicap (8-18 min)

Modèle 1 — Médical et réadaptatif

Le modèle médical conçoit le handicap comme une **déficiences individuelle à corriger**. Émergeant à la fin du XIX^e siècle avec l'institutionnalisation de la médecine de réadaptation¹⁴, il se consolide au sortir des deux guerres mondiales avec l'invalidité de guerre puis du travail¹⁵. Sa traduction administrative la plus visible en Suisse est l'AI¹⁶.

Posture professionnelle qu'il appelle : le TS comme **technicien de la conformité**. Il accompagne la personne dans son ajustement à des normes implicites de productivité, d'autonomie fonctionnelle, de comportement adapté. Cette posture n'a pas disparu : elle reste structurante dans l'évaluation AI¹⁷ et dans certains dispositifs de réadaptation professionnelle¹⁸.

Modèle 2 — Social (Oliver, UPIAS 1976)

Le modèle social britannique opère une rupture conceptuelle radicale : le handicap n'est pas la déficiences corporelle (*impairment*) mais le **handicap social produit par les barrières environnementales** (*disability*). La formulation princeps est celle de l'*Union of the Physically Impaired Against Segregation* (UPIAS) en 1976 : « *Disability is something imposed on top of our impairments by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society* »¹⁹.

Posture professionnelle qu'il appelle : le TS comme **acteur du changement environnemental**. Il agit moins sur la personne que sur les barrières qui la « handicapent ». Le modèle social a été critiqué — parfois durement, notamment depuis l'expérience féministe et de la maladie chronique — pour minorer la souffrance corporelle et l'expérience subjective de la déficiences²⁰. Ces critiques ont conduit à des reformulations contemporaines (*critical disability studies*, *crip theory*) qui maintiennent la centralité de l'analyse politique tout en réintégrant le corps²¹.

¹¹ Charlton, J. I. (1998). *Nothing About Us Without Us. Disability Oppression and Empowerment*. Berkeley : University of California Press. Barnes, C., & Mercer, G. (2010). *Exploring Disability* (2^e éd.). Cambridge : Polity Press. Shakespeare, T. (2014). *Disability Rights and Wrongs Revisited* (2^e éd.). Londres : Routledge. Goodley, D. (2017). *Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction* (2^e éd.). Londres : Sage.

¹² Ville, Fillion & Ravaud (2020), op. cit. Voir aussi Blanc, A. (2012). *Sociologie du handicap*. Paris : Armand Colin ; Calvez, M. (2000). La sociologie du handicap. *Sciences sociales et santé*, 18(4), 105-119.

¹³ Organisation des Nations Unies (2006). *Convention relative aux droits des personnes handicapées* (CDPH). New York : ONU. Ratifiée par la Suisse le 15 avril 2014, en vigueur 15 mai 2014. Pour l'historique du processus, voir Quinn, G., & Degener, T. (2002). *Human Rights and Disability. The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability*. Genève : Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

¹⁴ Stiker, H.-J. (1982/2013), op. cit., chapitres IV-V. La réadaptation s'institutionnalise comme paradigme moderne autour de la « pension d'invalidité » et de la « rééducation fonctionnelle ».

¹⁵ Sur l'invalidité de guerre comme matrice : Prost, A. (1977). *Les Anciens Combattants et la société française, 1914-1939*. Paris : Presses de la FNSP. Sur l'invalidité du travail : Buton, F. (2007). Les corps saisis par l'État : l'identification des personnes handicapées dans la France contemporaine. *Revue française de science politique*, 57(3-4), 333-360.

¹⁶ Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), RS 831.20, 19 juin 1959. Pour une lecture critique de l'architecture institutionnelle de l'AI, voir Tabin, J.-P., Probst, I., Waardenburg, G., & Bruttin, J. (2019). *Repenser la normalité. Réflexions sur l'invalidité*. Lausanne : Antipodes ; Probst, I. (2012). *Logiques d'attribution et trajectoires des bénéficiaires de l'assurance-invalidité*. Thèse de doctorat, Université de Lausanne.

¹⁷ Sur la persistance de l'évaluation médicale de l'invalidité : Probst, I., & Tabin, J.-P. (2017). De la justice à l'arbitraire : la mise en œuvre de l'assurance-invalidité en Suisse. *Revue française des affaires sociales*, (4), 87-105.

¹⁸ Voir notamment le rapport Berclaz, M. (2019). *La réadaptation professionnelle dans l'AI*. Berne : OFAS.

¹⁹ UPIAS (1976). *Fundamental Principles of Disability*. Londres : Union of the Physically Impaired Against Segregation. Repris et systématisé par Oliver, M. (1990), op. cit., p. 11. Voir aussi Finkelstein, V. (1980). *Attitudes and Disabled People : Issues for Discussion*. New York : World Rehabilitation Fund.

²⁰ Crow, L. (1996). Including all of our lives : Renewing the social model of disability. In C. Barnes & G. Mercer (Eds.), *Exploring the Divide*. Leeds : The Disability Press, pp. 55-72. French, S. (1993). Disability, impairment or something in between ? In J. Swain et al. (Eds.), *Disabling Barriers — Enabling Environments*. Londres : Sage, pp. 17-25. Shakespeare, T. (2014), op. cit.

²¹ McRuer, R. (2006). *Crip Theory. Cultural Signs of Queerness and Disability*. New York : NYU Press. Goodley, D. (2017), op. cit. Pour la francophonie : Masson, D. (2013). Femmes et handicap. *Recherches féministes*, 26(1), 111-129.

Modèle 3 — MDH-PPH / RIPPH (Fougeyrollas 2010)

Le **Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH)**, développé par Patrick Fougeyrollas et le Réseau international du processus de production du handicap (RIPPH) au Québec, propose une synthèse interactive²². Le handicap n'est ni dans la personne ni dans l'environnement, mais dans leur **rencontre**. L'auteur mobilise la métaphore du *funambule, du fil et de la toile* : la personne (funambule) avance sur un fil (habitudes de vie) tendu dans une toile (environnement). Une situation de handicap est ce qui se produit quand la qualité de la toile ne soutient pas le passage.

Posture professionnelle qu'il appelle : le TS comme **évaluateur situationnel**. Il cartographie les facilitateurs et les obstacles dans l'environnement de la personne, identifie les habitudes de vie compromises, négocie des aménagements. C'est ce modèle qui structure la recherche romande sur l'accessibilité et la participation sociale, notamment à la HETS Genève²³.

Modèle 4 — Droits humains et capacités

Le quatrième modèle émerge à la jonction du droit international des droits humains et de la philosophie politique post-rawlsienne.

D'un côté, la **CDPH ONU 2006**²⁴ consacre le passage d'une approche de protection (charity, welfare) à une approche de droits (rights-based). La personne handicapée est sujet de droits égaux. L'article 12 reconnaît la capacité juridique universelle et substitue au paradigme de la **substitution de décision** (tutelle, curatelle de portée générale) celui du **soutien à la décision** (*supported decision-making*)²⁵. L'article 19 consacre le droit à la vie autonome dans la communauté. L'article 24 le droit à l'éducation inclusive.

De l'autre, l'**approche par les capacités** initiée par Amartya Sen²⁶ et systématisée pour les personnes handicapées par Martha Nussbaum²⁷ propose une alternative au contractualisme rawlsien. Pour Nussbaum, la *Théorie de la justice* échoue à inclure les personnes lourdement handicapées car elle présuppose des contractants libres, rationnels et productifs. L'approche par les capacités garantit à chacun·e un seuil minimal de **dix capacités centrales** — vie, santé corporelle, intégrité corporelle, sens-imagination-pensée, émotions, raison pratique, affiliation, autres espèces, jeu, contrôle de son environnement — comme conditions d'une vie digne. La notion de capacité (par opposition à celle de fonctionnement) capte ce que la personne peut effectivement faire et être, compte tenu de ses ressources personnelles et des supports environnementaux.

Posture professionnelle qu'il appelle : le TS comme **garant de droits et facilitateur de capacités**. Il connaît le cadre légal, sait l'invoquer, sait l'expliquer ; il évalue moins des « besoins » ou des « manques » que des **capacités à soutenir**²⁸.

²²Fougeyrollas, P. (2010), op. cit. Pour une version opérationnalisée : Réseau international du processus de production du handicap (RIPPH) (2018). *Classification internationale Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH)*. Québec : RIPPH. L'outil *Mesure des habitudes de vie* (MHAVIE) dérive directement de ce cadre.

²³Masse, M., Petitpierre, G., Delessert, Y., Jacquemettaz, M., & Wolf, J.-P. (2018). *Accessibilité et participation sociale. Quelles avancées, quelles résistances ?* Genève : Éditions ies. Cette recherche mobilise le MDH-PPH pour analyser 47 institutions romandes auprès d'environ 7 000 adultes avec déficience intellectuelle. Pour la diffusion francophone du modèle : Boucher, N. (2003). Handicap, recherche et changement social. *Service social*, 50(1), 147-164.

²⁴ONU (2006), op. cit. Préambule, considérant (e) : « Reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. » Pour le commentaire juridique de référence : Bantekas, I., Stein, M. A., & Anastasiou, D. (Eds.) (2018). *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A Commentary*. Oxford : Oxford University Press.

²⁵Sur la mutation paradigmatique opérée par l'article 12 : Quinn, G. (2010). *Personhood and Legal Capacity. Perspectives on the Paradigm Shift of Article 12 CRPD*. Communication, HPOD Conference, Harvard Law School. Pour la critique du retard suisse en la matière : Comité ONU CDPH (2022). *Observations finales concernant le rapport initial de la Suisse*. CRPD/C/CHE/CO/1, 13 avril 2022, § 22-23.

²⁶Sen, A. (1985). *Commodities and Capabilities*. Amsterdam : North-Holland. Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford : Oxford University Press. Pour la transposition au handicap : Mitra, S. (2006). The capability approach and disability. *Journal of Disability Policy Studies*, 16(4), 236-247.

²⁷Nussbaum, M. (2006), op. cit. Pour le débat avec les *crip studies* : Wolff, J., & De-Shalit, A. (2007). *Disadvantage*. Oxford : Oxford University Press. Pour une discussion francophone : Astier, I. (2009). Les transformations de la relation d'aide dans l'intervention sociale. *Informations sociales*, 152, 52-58.

²⁸Sur cette posture appliquée au travail social : Otto, H.-U., & Ziegler, H. (Eds.) (2010). *Capabilities — Handlungsbefähigung und Verwirklichungschancen in der Erziehungswissenschaft*. Wiesbaden : VS Verlag. Pour la francophonie : Bonvin, J.-M., & Farvaque, N. (2008). *Amartya Sen. Une politique de la liberté*. Paris : Michalon. Bonvin enseigne à l'Université de Lausanne et a beaucoup travaillé sur la transposition de Sen aux politiques sociales suisses.

Une grille opérationnelle

Modèle	Idée centrale	Posture professionnelle	Risque
Médical / réadaptatif	Le handicap est une déficience à corriger	Technicien de la conformité	Adapter la personne à un environnement non interrogé
Social (Oliver)	Le handicap est produit par les barrières	Acteur du changement environnemental	Minorer la souffrance corporelle
MDH-PPH	Le handicap résulte d'une interaction	Évaluateur situationnel	Complexité difficile à opérationnaliser
Droits + capacités	La personne est sujet de droits, ce qui compte est la capacité réelle	Garant de droits et facilitateur	Effectivité variable des droits proclamés

Ces modèles **ne sont pas des étapes successives**. Ils coexistent dans chaque institution comme **grammaires actives**²⁹. Reconnaître le modèle dominant d'une institution, c'est déjà commencer à y intervenir.

5.3 Les transformations contemporaines (19-28 min)

Désinstitutionnalisation

L'article 19 CDPH pose le droit de « **vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes** ». Sa mise en œuvre est précisément ce que le Comité ONU CDPH a critiqué dans ses Observations finales sur la Suisse du 13 avril 2022³⁰ : « *The Committee is concerned about the lack of a comprehensive deinstitutionalization strategy* » (§ 41), recommandant d'« *adopt a deinstitutionalization strategy with a clear time frame* » (§ 42).

La Suisse a répondu de manière hétérogène. **L'Initiative populaire fédérale « Pour l'inclusion »**, déposée le 5 septembre 2024 avec **107 910 signatures validées** sur 109 110, demande l'inscription constitutionnelle de l'égalité, de la participation, de l'autodétermination et du droit à l'assistance personnelle³¹. Le **contre-projet indirect du Conseil fédéral**, dont le message a été adopté le 25 février 2026, est jugé insuffisant par Inclusion Handicap et AGILE.CH³².

À Genève, deux instruments structurent l'agenda : le **plan cantonal de mise en œuvre de la CDPH (volume 1)** publié en janvier 2023³³, et l'**avant-projet de Loi sur l'égalité et les droits des personnes handicapées (LED-H)** mis en consultation le 12 juin 2024, co-construit avec une quarantaine d'organisations³⁴.

La désinstitutionnalisation ne saurait toutefois être réduite à la **fermeture d'établissements**. La position de l'IASSIDD, formalisée par Mansell et Beadle-Brown, est sans équivoque : « *Community-based services are typically associated with better outcomes than institutional provision, but outcomes vary widely depending on how services are organised* »³⁵. Sans investissement substantiel dans les services de proximité, la fermeture des

²⁹ La métaphore de la « grammaire » est inspirée du pluralisme normatif de Boltanski et Thévenot et de la sociologie pragmatique. Voir Boltanski, L., & Thévenot, L. (1991). *De la justification. Les économies de la grandeur*. Paris : Gallimard. Pour son application au champ du handicap : Revillard, A. (2020). *Des droits vulnérables. Handicap, action publique et changement social*. Paris : Presses de Sciences Po, notamment chap. 1.

³⁰ Comité ONU CDPH (2022), op. cit. Le rapport comporte 80+ recommandations. Pour une analyse française : Cojean, P. (2022). La Suisse rappelée à l'ordre par le Comité ONU CDPH. *REISO*, [en ligne].

³¹ Comité d'initiative « Pour l'inclusion » (2024). *Initiative populaire fédérale « Pour l'égalité des personnes en situation de handicap (Initiative pour l'inclusion) »*. Berne. Voir aussi les positions d'Inclusion Handicap (2024-2025).

³² Conseil fédéral (2026). *Message concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire « Pour l'inclusion »*. Berne, 25 février 2026. Critique d'Inclusion Handicap (2026), communiqué de presse. Critique d'AGILE.CH (2026), prise de position.

³³ État de Genève, Département de la cohésion sociale (DCS) (2023). *Plan d'action cantonal de mise en œuvre de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. Volume 1*. Genève. Pour le suivi opérationnel, voir les rapports d'étape de la Commission consultative cantonale CDPH.

³⁴ État de Genève, DCS (2024). *Avant-projet de Loi sur l'égalité et les droits des personnes handicapées (LED-H)*. Consultation publique ouverte le 12 juin 2024. Pour la cartographie des co-constructions, voir le rapport de synthèse de la consultation (2025).

³⁵ Mansell & Beadle-Brown (2010), op. cit., p. 106. Voir aussi Bigby, C., & Beadle-Brown, J. (2018). Improving quality of life outcomes in supported accommodation for people with intellectual disability. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 31(2), 182-200.

grands établissements produit de la **transinstitutionnalisation** — déplacement vers d'autres formes de ségrégation — ou des situations de **non-recours** aggravées³⁶. L'ENIL documente que des fonds structurels européens continuent à financer la rénovation d'institutions au lieu de l'assistance personnelle³⁷.

Autodétermination, agentivité, pair-aidance

L'autodétermination s'est imposée dans le champ du handicap intellectuel comme principe organisateur des pratiques. Sa formulation théorique la plus diffusée est due à Michael Wehmeyer³⁸ : agir comme l'**agent causal principal** de sa propre vie, sur la base de quatre caractéristiques (autonomie comportementale, autorégulation, *empowerment* psychologique, autoréalisation). Ce modèle fonctionnel a été enrichi par Lachapelle, Wehmeyer et Shogren d'une perspective développementale et écosystémique : l'autodétermination est moins un trait individuel qu'à entraîner qu'un produit relationnel inscrit dans une trajectoire et soutenu par des opportunités d'apprentissage³⁹.

L'arrière-plan théorique large est celui de la **théorie de l'autodétermination** de Ryan et Deci, qui identifie trois besoins psychologiques universels : autonomie, compétence, appartenance⁴⁰. « *Autonomy, competence, and relatedness are not just preferences but universal psychological necessities* ». L'enjeu pour le travail social est de **soutenir l'autonomie** plutôt que de la contrôler ou de la contraindre — distinction opérationnelle décisive.

En articulation, la **pair-aidance** et les **savoirs expérientiels** constituent une transformation majeure du rapport entre savoir profane et savoir professionnel. La cartographie pionnière de Jouet, Flora et Las Vergnas a documenté la production de savoirs spécifiques par les personnes concernées : « *Les patients développent, au fil de l'expérience de la maladie, des savoirs spécifiques qui ne sont pas réductibles aux savoirs médicaux* »⁴¹. La Haute Autorité de santé française a inscrit en 2022 la pair-aidance dans ses recommandations de bonnes pratiques pour le secteur du handicap intellectuel⁴².

À Genève, plusieurs recherches HETS portent sur la pair-aidance et l'habitat autonome dans le champ de la déficience intellectuelle, notamment celles de Manon Masse, Chloé Souesme et Yves Delessert⁴³. Souesme a récemment publié dans *REISO* une analyse opérationnelle : « *Des pair-e-s pour faciliter l'habitat autonome* »⁴⁴.

Cette transformation pose toutefois une question critique posée par Brasseur et Rodriguez⁴⁵ : « *Les personnes handicapées sont invitées à témoigner de leur expérience pendant que les valides en produisent l'analyse.* » La participation se déploie selon « *une économie inégale de la parole* » qui peut reconduire l'asymétrie qu'elle prétend défaire. La pair-aidance institutionnalisée doit s'accompagner d'un travail réflexif sur les rapports de pouvoir épistémique.

³⁶ Sur le non-recours dans le champ du handicap suisse : Lucas, B. (2022). *Care, droits et citoyenneté. Voix des personnes âgées dans les institutions*. Genève : HETS Genève (Programme PNR 74). Sur les effets de transinstitutionnalisation : Power, A. (2013). Making space for belonging : Critical reflections on the implementation of personalised adult social care. *Social Science & Medicine*, 88, 68-75.

³⁷ European Network on Independent Living (ENIL) (2023). *Report on the use of European Structural and Investment Funds*. Bruxelles : ENIL. Pour la position politique d'ENIL : « *Independent Living means having the same choices and control over our every-day lives as our non-disabled brothers and sisters* » (Adolf Ratzka).

³⁸ Wehmeyer, M. (1996), op. cit. Voir aussi Wehmeyer, M., Shogren, K., & Toste, J. (2017). Self-determined learning to motivate struggling learners in reading and writing. *Intervention in School and Clinic*, 52(5), 295-303.

³⁹ Lachapelle, Y., Wehmeyer, M. L., & Shogren, K. A. (2022). Articulation entre Causal Agency Theory et perspectives écosystémiques dans l'autodétermination des personnes ayant une déficience intellectuelle. *La Nouvelle Revue – Éducation et société inclusives*, 94(2). Voir aussi Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., et al. (2015). Causal Agency Theory : Reconceptualizing a functional model of self-determination. *Education and Training in Autism and Developmental Disabilities*, 50(3), 251-263.

⁴⁰ Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017), op. cit., p. 86. Pour la transposition aux contextes d'accompagnement : Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The « what » and « why » of goal pursuits : Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.

⁴¹ Jouet, E., Flora, L., & Las Vergnas, O. (2010). Construction et reconnaissance des savoirs expérientiels des patients. *Pratiques de formation – Analyses*, 58-59. Pour le secteur santé mentale : Pachoud, B., & Corbière, M. (2014). Pratiques et interventions de soutien à l'insertion professionnelle des personnes ayant un trouble psychique. *L'Évolution psychiatrique*, 79(3), 365-381.

⁴² Haute Autorité de Santé (HAS) (2022). *Autodétermination, participation et citoyenneté des personnes accompagnées en établissements et services accueillant des adultes handicapés*. TDI Volet 1. Paris : HAS.

⁴³ Masse, M. et al. (2018), op. cit. Voir aussi Petitpierre, G., Masse, M., & Wolf, J.-P. (2020). Inclusion sociale et déficience intellectuelle. Genève : HETS.

⁴⁴ Souesme, C. (2024). Des pair-e-s pour faciliter l'habitat autonome. *REISO – Revue d'information sociale*, [en ligne].

⁴⁵ Brasseur, P., & Rodriguez, J. (2019). Les handicapés témoins, les valides experts. La division sociale du travail dans des dispositifs participatifs sur la sexualité des personnes handicapées. *Participations. Revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté*, 22(3), 139-158. Pour une analyse complémentaire : Brasseur, P. (2024). *Sociologie de l'assistance sexuelle. Travail du care, travail sexuel et politiques du handicap*. Paris : PUF.

Financement orienté personne : la contribution d'assistance AI

Le financement *cash-for-care* introduit une logique nouvelle : la personne reçoit l'argent et engage elle-même ses assistant-es. La Suisse l'a introduit le 1^{er} janvier 2012 par la 6^e révision de la LAI⁴⁶. Le rapport d'évaluation finale OFAS 2020 donne les chiffres : environ **2 600 bénéficiaires** fin 2019 (cible initiale 3 000 dès 2012), durée moyenne d'engagement d'assistants 41 h/semaine, **81 % de satisfaction**, rares retours en home⁴⁷.

La perspective comparée éclaire les limites de la transformation. Le Bihan, Da Roit et Sopadzhyan analysent les politiques *cash-for-care* en France, Italie et Pays-Bas comme un « *familialisme optionnel par le marché* » : les familles continuent à produire l'essentiel de l'aide mais peuvent acheter du soin sur un marché concurrentiel, au prix d'une précarisation des aidants professionnels — souvent des femmes migrantes⁴⁸. Glendinning, étudiant les *individual budgets* anglais, observe que « *personalisation marks a shift from the citizen-as-recipient to the citizen-as-purchaser of care* » — déplacement qui n'est pas neutre⁴⁹.

Retour à Léa. La contribution d'assistance constitue l'un des outils qui rendraient son projet juridiquement possible. Elle n'est pas sous curatelle de portée générale — elle est donc éligible. Mais : sait-elle qu'elle existe ? Sait-elle remplir le formulaire ? Connaît-elle ses droits de recours ? L'effectivité dépendra du travail d'**intermédiation** assuré par l'équipe, par Pro Infirmis, par Cap-Contact⁵⁰. C'est précisément ce que Revillard appelle des **droits vulnérables** : « *Les droits ne sont pas seulement ce que les textes disent, mais ce que les personnes parviennent à en faire* »⁵¹.

5.4 Les trois tensions de la posture professionnelle (29-33 min)

Tension 1 — Protection / Autonomie

Robert Perske formule en 1972 ce qui demeure l'une des phrases les plus citées du champ : « *There can be such a thing as human dignity in risk. And there can be a dehumanizing indignity in safety!* »⁵² La **dignité du risque** signifie que les personnes ayant une déficience intellectuelle ont droit à prendre des risques ordinaires : travailler, aimer, voyager, se tromper. Surprotéger nie l'humanité de la personne.

L'article 12 CDPH opère le déplacement juridique correspondant : **du paradigme tutélaire** (substitution de décision) **au paradigme du soutien** (*supported decision-making*). En Suisse, l'application reste partielle : la curatelle de portée générale (CC art. 398) demeure couramment ordonnée, en contradiction avec la lecture stricte de l'art. 12 CDPH soutenue par le Comité ONU CDPH⁵³.

La résolution de cette tension n'est pas dans le choix univoque de l'autonomie contre la protection. Elle est dans une **éthique du care** qui pense la vulnérabilité comme constitutive de la condition humaine. Joan Tronto déplace le care de l'éthique privée vers la philosophie politique : « *Nous sommes tous des êtres vulnérables et dépendants. Il s'agit de redistribuer la responsabilité du care, non de la concentrer sur les plus faibles* »⁵⁴. Patricia Paperman

⁴⁶Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 6^e révision, entrée en vigueur 1^{er} janvier 2012. Pour la genèse politique : Fracheboud, V., & Lehmann, C. (2019). L'introduction de la contribution d'assistance en Suisse : entre autodétermination et limites administratives. *Revue suisse de travail social*, 26, 11-28.

⁴⁷OFAS (2020), op. cit. Analyse critique : Inclusion Handicap (2022). *Position sur la contribution d'assistance*. Berne. AGILE.CH (2023). *Vie autodéterminée*, dossier thématique.

⁴⁸Le Bihan, B., Da Roit, B., & Sopadzhyan, A. (2019), op. cit. Pour le contexte plus large : Da Roit, B., & Le Bihan, B. (2010). Similar and yet so different : Cash-for-care in six European countries' long-term care policies. *The Milbank Quarterly*, 88(3), 286-309.

⁴⁹Glendinning, C. (2008), op. cit. Pour le rapport d'évaluation : Glendinning, C., et al. (2008). *Evaluation of the Individual Budgets Pilot Programme*. York : Social Policy Research Unit.

⁵⁰Pro Infirmis Genève fournit une consultation sociale et un conseil spécialisé en accès aux droits AI. Cap-Contact est une association romande spécifiquement orientée vers les droits des personnes avec déficience intellectuelle. Pour leur articulation, voir le plan cantonal CDPH 2023.

⁵¹Revillard, A. (2020), op. cit. Voir aussi Revillard, A. (2017). La réception du droit du handicap. Du droit aux dispositions. *Droit et société*, 96(2), 269-285.

⁵²Perske, R. (1972). The dignity of risk and the mentally retarded. *Mental Retardation*, 10(1), 24-27. Pour la transposition contemporaine : Robertson, J., & Emerson, E. (2010). *Health and wellbeing of adults with intellectual disabilities in transition*. Lancaster : Lancaster University.

⁵³Comité ONU CDPH (2014). *Observation générale n° 1. Article 12 : Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité*. CRPD/C/GC/1. Observations sur la Suisse (2022), § 22-23. Pour la jurisprudence suisse : Maître, V. (2021). *La capacité juridique des personnes avec handicap intellectuel*. Berne : Stämpfli.

⁵⁴Tronto, J. (2009), op. cit. Pour la formulation princeps : Fisher, B., & Tronto, J. (1990). Toward a feminist theory of caring. In E. Abel & M. Nelson (Eds.), *Circles of Care*. Albany : SUNY Press, pp. 36-54 : « *Le care est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre "monde"* ».

et Sandra Laugier ont introduit ces *care ethics* dans le débat francophone⁵⁵ ; Pascale Molinier en a développé la dimension empirique⁵⁶.

Tension 2 — Expertise professionnelle / Savoir expérientiel

La formule « *Nothing about us without us* » de James Charlton⁵⁷ est plus qu'un slogan : c'est une **épistémologie politique**. Aucune décision concernant les personnes handicapées ne saurait être prise sans leur participation directe. La pair-aidance, l'auto-représentation associative (AGILE.CH, *self-advocacy*), la co-recherche transforment progressivement les pratiques du champ.

Mais cette transformation rencontre des résistances objectives. Comme l'a montré Brasseur avec Rodriguez, les dispositifs participatifs reproduisent souvent une **division épistémique** : personnes concernées comme *témoins*, valides comme *experts*⁵⁸. La pair-aidance institutionnalisée doit s'accompagner d'un travail réflexif et structurel — statut, rémunération, formation, supervision — sans lequel elle risque de devenir une nouvelle injonction.

Tension 3 — Travail prescrit / Travail réel

La clinique de l'activité d'Yves Clot fournit la grammaire conceptuelle de cette tension. Le **travail prescrit** (référentiels d'activité, procédures institutionnelles, contraintes du financement) n'est jamais identique à l'**activité réelle** déployée par les professionnel·les en situation, qui inclut ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui aurait pu être fait, ce qui est empêché⁵⁹. Quand le **genre professionnel** (les manières de faire propres au métier, déposées dans le collectif) s'effrite, le **pouvoir d'agir** se réduit et la souffrance s'installe : « *Ce qui rend malade au travail, ce n'est pas le conflit, c'est l'impossibilité du conflit* »⁶⁰.

Michael Lipsky en a fourni la sociologie politique : « *The decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the devices they invent to cope with uncertainties and work pressures effectively become the public policies they carry out* »⁶¹. Les travailleur·euses sociaux·ales ne sont pas seulement des exécutant·es : illes sont des **producteur·trices de politique publique au guichet**, exerçant une *autonomie discrétionnaire* qui peut être un levier d'éthique professionnelle ou une zone de reproduction inégalitaire.

Vincent Dubois en a tiré une ethnographie : le guichet articule contraintes bureaucratiques, demandes sociales, travail relationnel ; l'agent oscille entre rôle administratif et rôle social⁶². Et Catherine Lenzi vient récemment de prolonger cette tradition avec Alexandre Moine, dans *Des pas de côté dans le travail social. Le métier dans toutes ses marges*, qui rassemble des analyses de l'autonomie discrétionnaire dans les marges des dispositifs⁶³.

Une dimension reste sous-thématisée dans cette tradition : le **travail émotionnel**. Arlie Hochschild a montré que dans l'économie de services, les travailleur·euses doivent produire des émotions appropriées au rôle attendu : « *This labor requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the outward countenance that produces the proper state of mind in others* »⁶⁴. Annoncer un refus AI, accompagner une fin de droits, recadrer un proche : autant de situations où le travail émotionnel est central, invisible dans les fiches de poste, coûteux psychiquement.

⁵⁵ Paperman, P., & Laugier, S. (Eds.) (2006/2011). *Le souci des autres. Éthique et politique du care*. Paris : Éditions de l'EHESS. Voir aussi Laugier, S. (2010). *L'éthique du care*. Paris : Vrin.

⁵⁶ Molinier, P., Laugier, S., & Paperman, P. (Eds.) (2009). *Qu'est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité*. Paris : Payot. Molinier, P. (2013). *Le travail du care*. Paris : La Dispute.

⁵⁷ Charlton, J. (1998), op. cit. La phrase circule dans le mouvement international du handicap depuis les années 1990 et a guidé la rédaction de la CDPH. Pour son histoire : « *Disability oppression is a totalizing system* » — la phrase encadre l'ensemble du livre.

⁵⁸ Brasseur & Rodriguez (2019), op. cit. Pour des prolongements : Brasseur, P. (2024), op. cit. ; Stiker, H.-J., Puig, J., & Huet, A. (2014). *Handicap et accompagnement. Nouvelles attentes, nouvelles pratiques*. Paris : Dunod.

⁵⁹ Clot, Y. (1999). *La fonction psychologique du travail*. Paris : PUF.

⁶⁰ Clot, Y. (2008), op. cit. La méthode de l'autoconfrontation croisée permet de rendre visible le « réel de l'activité » et de réoutiller le collectif de travail. Voir aussi Clot, Y. (2010). *Le travail à cœur*. Paris : La Découverte.

⁶¹ Lipsky, M. (1980/2010), op. cit., p. xii. Pour des prolongements suisses : Cattacin, S. (2006). The politics of social cohesion. *European Societies*, 8(1), 35-62.

⁶² Dubois, V. (2010). *La vie au guichet. Administrer la misère* (3^e éd.). Paris : Économica. Pour la version anglaise : Dubois, V. (2020). *The Bureaucrat and the Poor : Encounters in French Welfare Offices*. Londres : Routledge.

⁶³ Lenzi, C., & Moine, A. (Eds.) (2025). *Des pas de côté dans le travail social. Le métier dans toutes ses marges*. Nîmes : Champ social, 272 p. Catherine Lenzi est professeure associée à la HETS Genève et anime le réseau de compétences « Autonomie-Handicap-Dépendance ».

⁶⁴ Hochschild, A. R. (1983). *The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling*. Berkeley : University of California Press, p. 7. Pour la transposition aux métiers du social : Soares, A. (2002). Le travail émotionnel des caissières. *Travailler*, 8(2), 105-118.

Donald Schön rappelle enfin que les professionnel·les compétent·es ne se contentent pas d'appliquer des savoirs académiques (rationalité technique) mais conduisent une *reflection-in-action* qui leur permet d'affronter incertitude, singularité, conflits de valeurs⁶⁵. « *Les praticiens compétents en savent généralement plus qu'ils ne peuvent en dire.* »

5.5 Activité d'application *think-pair-share* (33-38 min)

Consigne. « Choisissez l'une des trois tensions. Seul·e, 2 minutes : prenez position. En binôme, 2 minutes : formulez en deux phrases ce que vous diriez à Léa, à sa mère et à l'équipe. Restitution : 3 binômes, un par tension, 1 minute chacun. Il n'y a pas de bonne réponse — une posture argumentée. »

L'activité mobilise la stratégie pédagogique du *think-pair-share* documentée par Lyman⁶⁶. Sa fonction est double : (1) permettre à chacun·e de mobiliser les concepts présentés en lien avec une situation concrète ; (2) faire émerger la pluralité des réponses possibles, qui correspond à la pluralité des modèles. La posture de l'enseignant est celle d'un **facilitateur** qui circule, reformule, renvoie aux concepts. Si un binôme répond « *on respecte le choix de Léa* », reformuler en notant « *vous mobilisez la dignité du risque de Perske et l'article 12 CDPH* ». Si un binôme répond « *on protège Léa* », reformuler en notant « *vous mobilisez l'éthique de protection — quels critères justifieraient-ils de limiter sa capacité juridique ?* »

5.6 Synthèse et ouverture (38-40 min)

Trois acquis à retenir.

1. Les modèles du handicap **ne sont pas des étapes successives** mais des **grammaires actives** qui coexistent dans chaque institution. Reconnaître le modèle dominant d'un dispositif, c'est déjà commencer à y intervenir⁶⁷.
2. Les transformations contemporaines suisses **ouvrent des marges d'action concrètes** pour les TS — CDPH, contribution d'assistance AI, Initiative pour l'inclusion 2024, plan cantonal genevois 2023, avant-projet LED-H — mais ces marges sont **droits vulnérables** dont l'effectivité dépend du travail d'intermédiation⁶⁸.
3. La posture professionnelle n'est pas un trait personnel : c'est un **travail réflexif quotidien** sur trois tensions structurelles⁶⁹. L'enjeu n'est pas de les résoudre une fois pour toutes mais de les habiter de manière argumentée.

Ouverture. La séance suivante portera sur « *Le travail avec les proches : entre alliés, opposants et co-aidants* » — la mère de Léa nous y accompagne. Les étudiant·es sont invité·es à apporter une situation rencontrée en formation pratique où la famille les a déstabilisé·es.

Lectures pour la prochaine séance. - Piérart, G. (Ed.) (2013). *Handicap, famille et migration*. Genève : IES, **chapitre 1**. - Revillard, A. (2020), op. cit., **chapitre 4** (sur le travail des bénéficiaires). - Comité ONU CDPH (2022), op. cit., **paragraphes sur l'article 23** (respect du domicile et de la famille).

6. Modalités d'évaluation des apprentissages de cette séance

Pour cette séance spécifique, deux modalités sont mobilisées :

⁶⁵Schön, D. A. (1983/1994), op. cit. Pour son actualisation : Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). *Organizational Learning II. Theory, Method, and Practice*. Reading (MA) : Addison-Wesley.

⁶⁶Lyman, F. T. (1981). The responsive classroom discussion. In A. S. Anderson (Ed.), *Mainstreaming Digest*. College Park : University of Maryland. Pour son application en pédagogie universitaire : Kaddouri, M. (2008). L'apprentissage coopératif en formation d'adultes. *Recherche et formation*, 58, 19-34.

⁶⁷Ville, Fillion & Ravaut (2020), op. cit. : « *Le handicap n'est pas un donné mais un construit historique, social et politique.* »

⁶⁸Revillard, A. (2020), op. cit. Voir aussi pour Genève : Lucas, B. (2022), op. cit.

⁶⁹Clot, Y. (2008) ; Schön (1983/1994) ; Lenzi & Moine (2025), op. cit.

1. **Évaluation formative en séance** : les micro-interactions (4 sur 40 minutes) permettent à l'enseignant d'observer la mobilisation des concepts par les étudiant-es. Aucune note, mais des retours immédiats.
2. **Évaluation formative différée** : dans le travail intermédiaire écrit du module (séance 7), les étudiant-es sont tenu-es de mobiliser les quatre modèles présentés ici pour analyser une situation de leur formation pratique.

L'évaluation sommative du module se fait au niveau du dossier final (séance 13). Les acquis de la présente séance y sont attendus dans la partie « cadrage théorique » et dans la justification des choix d'intervention.

7. Bibliographie complète (par ordre alphabétique)

- AGILE.CH (2023-2024). *Vie autodéterminée*. Dossier thématique. Berne : AGILE.CH — Organisations suisses des personnes avec handicap.
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). *Organizational Learning II. Theory, Method, and Practice*. Reading (MA) : Addison-Wesley.
- Astier, I. (2009). Les transformations de la relation d'aide dans l'intervention sociale. *Informations sociales*, 152, 52-58.
- Bantekas, I., Stein, M. A., & Anastasiou, D. (Eds.) (2018). *The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A Commentary*. Oxford : Oxford University Press.
- Barnes, C., & Mercer, G. (2010). *Exploring Disability* (2^e éd.). Cambridge : Polity Press.
- Berclaz, M. (2019). *La réadaptation professionnelle dans l'AI*. Berne : OFAS.
- Bigby, C., & Beadle-Brown, J. (2018). Improving quality of life outcomes in supported accommodation for people with intellectual disability. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 31(2), 182-200.
- Blanc, A. (2012). *Sociologie du handicap*. Paris : Armand Colin.
- Boltanski, L., & Thévenot, L. (1991). *De la justification. Les économies de la grandeur*. Paris : Gallimard.
- Bonvin, J.-M., & Farvaque, N. (2008). *Amartya Sen. Une politique de la liberté*. Paris : Michalon.
- Boucher, N. (2003). Handicap, recherche et changement social. *Service social*, 50(1), 147-164.
- Brasseur, P. (2024). *Sociologie de l'assistance sexuelle. Travail du care, travail sexuel et politiques du handicap*. Paris : PUF.
- Brasseur, P., & Rodriguez, J. (2019). Les handicapés témoins, les valides experts. *Participations*, 22(3), 139-158.
- Buton, F. (2007). Les corps saisis par l'État. *Revue française de science politique*, 57(3-4), 333-360.
- Calvez, M. (2000). La sociologie du handicap. *Sciences sociales et santé*, 18(4), 105-119.
- Cattacin, S. (2006). The politics of social cohesion. *European Societies*, 8(1), 35-62.
- Charlton, J. I. (1998). *Nothing About Us Without Us*. Berkeley : University of California Press.
- Clot, Y. (1999). *La fonction psychologique du travail*. Paris : PUF.
- Clot, Y. (2008). *Travail et pouvoir d'agir*. Paris : PUF.
- Clot, Y. (2010). *Le travail à cœur*. Paris : La Découverte.
- Cojean, P. (2022). La Suisse rappelée à l'ordre par le Comité ONU CDPH. *REISO*.
- Comité ONU CDPH (2014). *Observation générale n° 1. Article 12*. CRPD/C/GC/1.
- Comité ONU CDPH (2022). *Observations finales concernant le rapport initial de la Suisse*. CRPD/C/CHE/CO/1, 13 avril 2022.
- Conseil fédéral (2026). *Message concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire « Pour l'inclusion »*. Berne, 25 février 2026.

- Crow, L. (1996). Including all of our lives. In C. Barnes & G. Mercer (Eds.), *Exploring the Divide*. Leeds : The Disability Press, 55-72.
- Da Roit, B., & Le Bihan, B. (2010). Similar and yet so different : Cash-for-care in six European countries' long-term care policies. *The Milbank Quarterly*, 88(3), 286-309.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The « what » and « why » of goal pursuits. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268.
- Dubois, V. (2010). *La vie au guichet* (3^e éd.). Paris : Économica.
- Ebersold, S. (2017). *L'éducation inclusive. Privilège ou droit ?* Grenoble : PUG.
- ENIL (2023). *Report on the use of European Structural and Investment Funds*. Bruxelles : ENIL.
- État de Genève, DCS (2023). *Plan d'action cantonal de mise en œuvre de la CDPH. Volume 1*. Genève.
- État de Genève, DCS (2024). *Avant-projet de Loi sur l'égalité et les droits des personnes handicapées (LED-H)*. Genève.
- Finkelstein, V. (1980). *Attitudes and Disabled People*. New York : World Rehabilitation Fund.
- Fisher, B., & Tronto, J. (1990). Toward a feminist theory of caring. In E. Abel & M. Nelson (Eds.), *Circles of Care*. Albany : SUNY Press, 36-54.
- Fougeyrollas, P. (2010). *La funambule, le fil et la toile*. Québec : Presses de l'Université Laval.
- Fracheboud, V., & Lehmann, C. (2019). L'introduction de la contribution d'assistance en Suisse. *Revue suisse de travail social*, 26, 11-28.
- French, S. (1993). Disability, impairment or something in between ? In J. Swain et al. (Eds.), *Disabling Barriers — Enabling Environments*. Londres : Sage.
- Glendinning, C. (2008). Increasing choice and control. *Social Policy & Administration*, 42(5), 451-469.
- Glendinning, C., et al. (2008). *Evaluation of the Individual Budgets Pilot Programme*. York : SPRU.
- Goffman, E. (1963/1975). *Stigmaté*. Paris : Minuit.
- Goodley, D. (2017). *Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction* (2^e éd.). Londres : Sage.
- HAS (2022). *Autodétermination, participation et citoyenneté*. TDI Volet 1. Paris : HAS.
- Hochschild, A. R. (1983). *The Managed Heart*. Berkeley : University of California Press.
- Inclusion Handicap (2022). *Position sur la contribution d'assistance*. Berne.
- Inclusion Handicap (2022). *La Suisse en mauvaise position*. Communiqué. Berne.
- Jouet, E., Flora, L., & Las Vergnas, O. (2010). Construction et reconnaissance des savoirs expérientiels. *Pratiques de formation – Analyses*, 58-59.
- Kaddouri, M. (2008). L'apprentissage coopératif en formation d'adultes. *Recherche et formation*, 58, 19-34.
- Kittay, E. F. (1999). *Love's Labor*. New York : Routledge.
- Lachapelle, Y., Wehmeyer, M., & Shogren, K. (2022). *La Nouvelle Revue – Éducation et société inclusives*, 94(2).
- Laugier, S. (2010). *L'éthique du care*. Paris : Vrin.
- Le Bihan, B., Da Roit, B., & Sopadzhiyan, A. (2019). The turn to optional familialism through the market. *Social Policy & Administration*, 53(4), 579-595.
- Lenzi, C., & Moine, A. (Eds.) (2025). *Des pas de côté dans le travail social*. Nîmes : Champ social.
- Lipsky, M. (1980/2010). *Street-Level Bureaucracy* (30th anniv. ed.). New York : Russell Sage Foundation.
- Lucas, B. (2022). *Care, droits et citoyenneté*. Genève : HETS / PNR 74.
- Lyman, F. T. (1981). The responsive classroom discussion. In A. S. Anderson (Ed.), *Mainstreaming Digest*. College Park : University of Maryland.
- Maître, V. (2021). *La capacité juridique des personnes avec handicap intellectuel*. Berne : Stämpfli.

- Mansell, J., & Beadle-Brown, J. (2010). Deinstitutionalisation and community living. *Journal of Intellectual Disability Research*, 54(2), 104-112.
- Masse, M., Petitpierre, G., Delessert, Y., Jacquemettaz, M., & Wolf, J.-P. (2018). *Accessibilité et participation sociale*. Genève : Éditions IES.
- Masson, D. (2013). Femmes et handicap. *Recherches féministes*, 26(1), 111-129.
- McRuer, R. (2006). *Crip Theory*. New York : NYU Press.
- Mitra, S. (2006). The capability approach and disability. *Journal of Disability Policy Studies*, 16(4), 236-247.
- Molinier, P. (2013). *Le travail du care*. Paris : La Dispute.
- Molinier, P., Laugier, S., & Paperman, P. (Eds.) (2009). *Qu'est-ce que le care ?* Paris : Payot.
- Nussbaum, M. (2006). *Frontiers of Justice*. Cambridge (MA) : Belknap/Harvard.
- OFAS (2020). *Évaluation finale de la contribution d'assistance AI*. Berne : OFAS.
- OFS (2022). *Statistique de l'égalité des personnes handicapées*. Neuchâtel : OFS.
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Basingstoke : Macmillan.
- OMS (2001). *CIF – Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé*. Genève : OMS.
- ONU (2006). *Convention relative aux droits des personnes handicapées*. New York.
- Otto, H.-U., & Ziegler, H. (Eds.) (2010). *Capabilities*. Wiesbaden : VS Verlag.
- Pachoud, B., & Corbière, M. (2014). Pratiques et interventions de soutien à l'insertion professionnelle des personnes ayant un trouble psychique. *L'Évolution psychiatrique*, 79(3), 365-381.
- Paperman, P., & Laugier, S. (Eds.) (2006/2011). *Le souci des autres*. Paris : EHESS.
- Perske, R. (1972). The dignity of risk and the mentally retarded. *Mental Retardation*, 10(1), 24-27.
- Petitpierre, G., Masse, M., & Wolf, J.-P. (2020). *Inclusion sociale et déficience intellectuelle*. Genève : HETS.
- Piérart, G. (Ed.) (2013). *Handicap, famille et migration*. Genève : IES.
- Plaisance, É. (2009). *Autrement capables*. Paris : Autrement.
- Power, A. (2013). Making space for belonging. *Social Science & Medicine*, 88, 68-75.
- Probst, I. (2012). *Logiques d'attribution et trajectoires des bénéficiaires de l'AI*. Thèse de doctorat, Université de Lausanne.
- Probst, I., & Tabin, J.-P. (2017). De la justice à l'arbitraire. *Revue française des affaires sociales*, (4), 87-105.
- Prost, A. (1977). *Les Anciens Combattants et la société française*. Paris : Presses de la FNSP.
- Quinn, G. (2010). *Personhood and Legal Capacity*. Communication, Harvard Law School.
- Quinn, G., & Degener, T. (2002). *Human Rights and Disability*. Genève : HCDH.
- Revillard, A. (2017). La réception du droit du handicap. *Droit et société*, 96(2), 269-285.
- Revillard, A. (2020). *Des droits vulnérables*. Paris : Presses de Sciences Po.
- RIPPH (2018). *Classification internationale MDH-PPH*. Québec : RIPPH.
- Robertson, J., & Emerson, E. (2010). *Health and wellbeing of adults with intellectual disabilities in transition*. Lancaster.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-Determination Theory*. New York : Guilford.
- Schön, D. A. (1983/1994). *Le praticien réflexif*. Montréal : Éditions Logiques.
- Sen, A. (1985). *Commodities and Capabilities*. Amsterdam : North-Holland.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford : Oxford University Press.

- Shakespeare, T. (2014). *Disability Rights and Wrongs Revisited* (2^e éd.). Londres : Routledge.
- Shogren, K. A., Wehmeyer, M. L., et al. (2015). Causal Agency Theory. *Education and Training in Autism and Developmental Disabilities*, 50(3), 251-263.
- Soares, A. (2002). Le travail émotionnel des caissières. *Travailler*, 8(2), 105-118.
- Souesme, C. (2024). Des pair-e-s pour faciliter l'habitat autonome. *REISO*.
- Stiker, H.-J. (1982/2013). *Corps infirmes et sociétés* (3^e éd.). Paris : Dunod.
- Stiker, H.-J., Puig, J., & Huet, A. (2014). *Handicap et accompagnement*. Paris : Dunod.
- Tabin, J.-P., Probst, I., Waardenburg, G., & Bruttin, J. (2019). *Repenser la normalité*. Lausanne : Antipodes.
- Tronto, J. (2009). *Un monde vulnérable*. Paris : La Découverte.
- UPIAS (1976). *Fundamental Principles of Disability*. Londres.
- Ville, I., Fillion, E., & Ravaut, J.-F. (2020). *Introduction à la sociologie du handicap* (2^e éd.). Louvain-la-Neuve : De Boeck.
- Wehmeyer, M. (1996). Self-determination as an educational outcome. In D. J. Sands & M. L. Wehmeyer (Eds.), *Self-determination across the life span*. Baltimore : Brookes, 17-36.
- Wehmeyer, M., Shogren, K., & Toste, J. (2017). Self-determined learning to motivate struggling learners. *Intervention in School and Clinic*, 52(5), 295-303.
- Winance, M. (2007). Being normally different ? *Disability & Society*, 22(6), 625-638.
- Wolfensberger, W. (1983). Social Role Valorization : A proposed new term for the principle of normalization. *Mental Retardation*, 21(6), 234-239.
- Wolff, J., & De-Shalit, A. (2007). *Disadvantage*. Oxford : Oxford University Press.